Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Ventilasyon Tüpü Uygulaması / Miringotomi

Kulak zarına havalandırma tüpü takılması / kulak zarının açılarak sıvının boşaltılması

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Taraf: ☐ Sağ ☐ Sol ☐ İki taraf

Planlanan işlem:
☐ Miringotomi + ventilasyon tüpü
☐ Yalnızca miringotomi (tüp takılmadan)

Tüp tipi: ☐ Kısa süreli tüp ☐ Uzun süreli tüp (T-tüp vb.) _____

Aynı seansta yapılacak ek işlemler: ☐ Adenoidektomi ☐ Tonsillektomi ☐ Yok _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Orta kulak, kulak zarının arkasında bulunan ve normalde hava ile dolu olan küçük bir boşluktur. Bu boşluk, burnun arkasına açılan **östaki borusu** ile havalanır. Östaki borusu iyi çalışmadığında (özellikle çocuklarda, geniz eti büyüklüğü, alerji veya sık geçirilen soğuk algınlıkları nedeniyle) orta kulakta **sıvı birikir**.

Bu sıvı **işitme azlığına**, çocuklarda **konuşma ve dil gelişiminde gecikmeye**, dikkat sorunlarına, denge bozukluğuna ve **tekrarlayan kulak iltihaplarına** yol açabilir. Sıvı uzun süre kalırsa kulak zarında incelme, çökme ve kalıcı değişiklikler gelişebilir. Yetişkinlerde de benzer durumlar, uçuş/dalış sonrası basınç sorunları veya burun arkasındaki hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir.

Bu işlemin amacı, kulak zarına küçük bir açıklık yaparak sıvıyı boşaltmak ve takılan küçük tüp sayesinde orta kulağın havalanmasını sağlayarak **işitmeyi düzeltmek ve iltihapların sıklığını azaltmaktır.**

2 İşlem nasıl yapılır?

Çocuklarda işlem genellikle kısa süreli genel anestezi altında, yetişkinlerde ise çoğunlukla lokal anestezi ile yapılır. İşlem kulak kanalından, mikroskop altında yapılır; **dışarıda kesi veya iz yoktur.**

1. **Kulak kanalının temizlenmesi:** Mikroskop altında kulak kanalındaki kir temizlenir ve kulak zarı değerlendirilir.
2. **Miringotomi:** Kulak zarına, işitmeyi etkilemeyecek bir bölgeden yaklaşık 1–2 mm'lik küçük bir kesi yapılır.
3. **Sıvının boşaltılması:** Orta kulaktaki sıvı (berrak, yapışkan veya iltihaplı olabilir) ince bir aspiratör ile çekilir. Gerekirse sıvıdan kültür örneği alınabilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4. **Tüpün yerleştirilmesi:** Kesiye, birkaç milimetre boyutunda, makara şeklinde küçük bir tüp yerleştirilir. Bu tüp, östaki borusunun görevini geçici olarak üstlenerek orta kulağın havalanmasını sağlar.
5. **Bitirme:** Gerekirse kulak damlası uygulanır. Kulağa genellikle tampon konmaz veya yalnızca küçük bir pamuk konur.

Kısa süreli tüpler genellikle **6–18 ay** içinde, kulak zarı iyileşirken kendiliğinden dışarı itilir ve kulak kanalına düşer; çoğu zaman fark edilmez. **Uzun süreli tüpler** ise daha uzun süre yerinde kalır ve bazen ayrı bir işlemle çıkarılması gerekir.

Yalnızca miringotomi yapıldığında (tüp takılmadan) kulak zarındaki açıklık birkaç gün içinde kapanır ve sıvı tekrar birikebilir.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Çocuklarda genel anestezi; yetişkinlerde genellikle lokal anestezi	Her iki kulak için yaklaşık 10–20 dakika	Genellikle aynı gün taburculuk

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- İşitmenin genellikle hemen veya kısa sürede düzelmesi
- Çocuklarda konuşma, dil gelişimi, dikkat ve okul başarısına olumlu katkı
- Tekrarlayan kulak iltihaplarının sıklığının ve şiddetinin azalması; iltihap olduğunda çoğunlukla ağızdan antibiyotik yerine damla ile tedavi edilebilmesi
- Kulak zarında kalıcı hasar gelişme riskinin azalması; kulakta basınç ve dolgunluk hissinin geçmesi

Tüp yerinde ve açık olduğu sürece hastaların büyük çoğunluğunda işitme düzelir ve kulak iltihapları azalır. Tüp düştükten sonra östaki borusu yeterince gelişmişse sıvı genellikle tekrar birikmez. Ancak bazı çocuklarda (yaklaşık 100 çocuktan **20–30'unda**) sıvı yeniden birikebilir ve **tekrar tüp takılması** gerekebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Bekle-gör (izlem):** Orta kulak sıvısı birçok çocukta 3 ay içinde kendiliğinden geçebilir. İşitme kaybı hafifse ve risk faktörü yoksa düzenli işitme testleriyle izlem yapılabilir.
- **Otoinflasyon:** Özellikle büyük çocuklarda, burundan özel bir balonu şişirerek östaki borusunun açılmasına yardımcı olunabilir.
- **İşitme cihazı:** Ameliyat istemeyen veya uygun olmayan hastalarda sıvı devam ettiği sürece geçici bir çözüm olabilir.
- **İlaç tedavisi:** Alerji veya burun-sinüs hastalığı varsa tedavi edilir; ancak antibiyotik, kortizon veya burun spreylerinin orta kulak sıvısını kalıcı olarak geçirdiğine dair kanıt sınırlıdır.
- **Geniz eti ameliyatı:** Uygun çocuklarda tüp ile birlikte veya tekrar tüp gerektiğinde önerilebilir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

İşlem yapılmazsa sıvı bazı hastalarda kendiliğinden geçebilir, ancak devam ederse işitme azlığı, çocuklarda konuşma ve dil gelişiminde gecikme, dikkat ve okul sorunları, denge bozukluğu ve tekrarlayan kulak iltihapları sürebilir. Uzun süre devam eden sıvı, kulak zarında çökme (retraksiyon), kalıcı zar değişiklikleri, kemikçik hasarı ve nadiren **kolesteatom** gibi ameliyat gerektiren daha ciddi kulak hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- İşlemden önce işitme testi (odyometri) ve orta kulak basınç testi (timpanometri) yapılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Genel anestezi uygulanacaksa anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz; ameliyattan önceki **6 saat** boyunca katı gıda ve süt verilmemelidir, berrak sıvılar için anestezi uzmanının vereceği süreye uyunuz.
- İşlemden önceki 2 hafta içinde ateşli hastalık, öksürük veya grip geçirilirse bildiriniz; ameliyat ertelenebilir.
- Kulakta akıntı veya aktif iltihap varsa işlem öncesinde tedavi edilmesi gerekebilir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İşlem günü	Çoğu hasta birkaç saat içinde eve gider. Hafif kulak ağrısı veya dolgunluk hissi olabilir ve basit ağrı kesicilerle geçer. Kulakta birkaç gün süren hafif kanlı veya sulu akıntı olabilir. Çoğu hasta **sesleri hemen daha yüksek duyar**; bu durum ilk günlerde rahatsız edici gelebilir.
İlk 1 hafta	Hekiminiz önerdiyse kulak damlası kullanılır. Çocuklar 1–2 gün içinde okula/kreşe, yetişkinler işlerine dönebilir. Kulağa su kaçmamasına dikkat edilir.
4–8. haftalar	İlk kontrol muayenesi yapılır; tüpün yerinde ve açık olduğu kontrol edilir, işitme testi tekrarlanır.
Tüp yerinde kaldığı süre (6–18 ay)	Yaklaşık **3–6 ayda bir** kontrol önerilir. Kulak iltihabı olursa akıntı şeklinde kendini gösterir ve genellikle kulak damlası ile tedavi edilir. Uçak yolculuğu tüp varken genellikle daha rahattır.
Tüp düştükten sonra	Kulak zarındaki deliğin kapandığı ve orta kulakta sıvı olmadığı kontrol edilir; işitme testi yapılır.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Hafif kulak ağrısı ve dolgunluk hissi (1–2 gün)
- Kulakta birkaç gün süren hafif kanlı veya sulu akıntı
- Seslerin geçici olarak çok yüksek veya yankılı duyulması
- Genel anesteziye bağlı geçici bulantı, huzursuzluk

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Kulak akıntısı (otore)** — Tüp takılı olan hastaların yaklaşık 100'de **10–25'inde** en az bir kez kulak akıntısı olur; genellikle soğuk algınlığı veya kulağa su kaçması sonrasında görülür. Çoğu zaman antibiyotikli kulak damlası ile birkaç günde geçer. Nadiren akıntı inatçı olabilir ve ağızdan ilaç, kulak temizliği veya tüpün çıkarılması gerekebilir.
- **Kulak zarında beyaz lekeler (timpanoskleroz)** — Kulak zarında kireçlenme benzeri beyaz lekeler sık görülür (yaklaşık 100 kulakta **10–30+**). Çoğunlukla işitmeyi etkilemez.
- **Tüpün erken düşmesi veya tıkanması** — Tüp beklenenden önce düşebilir veya kurumuş kan/akıntı ile tıkanabilir. Bu durumda damla ile açılmaya çalışılır; gerekirse tüp yenilenir.
- **Tekrar tüp takılması gereği** — Tüp düştükten sonra sıvı yeniden birikirse, yaklaşık 100 çocuktan **20–30'unda** ikinci bir tüp uygulaması (bazen geniz eti ameliyatıyla birlikte) gerekebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Kulak zarında kalıcı delik (perforasyon)** — Tüp düştükten sonra kulak zarındaki delik kapanmayabilir: kısa süreli tüplerde 100 hastada yaklaşık **1–3**, uzun süreli tüplerde daha sık (yaklaşık **10–20**). Küçük delikler çoğu zaman şikâyet yapmaz; tekrarlayan akıntı veya işitme kaybına yol açarsa **ayrı bir ameliyatla (timpanoplasti/miringoplasti) kapatılması** gerekebilir.
- **Kulak zarında incelme veya çökme** — Tüpün bulunduğu bölgede zar incelebilir veya içe doğru çökebilir; takip gerekebilir.
- **Tüpün uzun süre düşmemesi** — Tüp beklenen sürede düşmezse (genellikle 2–3 yıldan uzun kalırsa) kısa bir işlemle çıkarılması gerekebilir; çocuklarda bu işlem genellikle genel anestezi altında yapılır.
- **Kulak kanalında doku üremesi (granülasyon)** — Tüpün çevresinde iltihaba bağlı kırmızı doku gelişebilir; kanlı akıntıya neden olabilir ve damla veya küçük bir işlemle tedavi edilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Tüpün orta kulağa kaçması** — Çok nadiren tüp dışarı düşmek yerine kulak zarının arkasına (orta kulağa) kayabilir; çıkarılması için ayrı bir işlem gerekebilir.
- **Kolesteatom** — Kulak zarının deri tabakasının orta kulağa doğru büyümesiyle oluşan bir kist benzeri hastalıktır. Tüp uygulamasına bağlı olarak **çok nadir** görülür. Gelişirse ameliyatla tedavisi gerekir.
- **İşitme kaybı, kulak çınlaması veya baş dönmesi** — İç kulak veya kemikçiklerin etkilenmesine bağlı kalıcı işitme kaybı, çınlama veya baş dönmesi **son derece nadirdir**.
- **Kulak kanalı yaralanması ve kanama** — Dar kulak kanallarında küçük yaralanmalar olabilir; çok nadiren yüz siniri, iç kulak veya büyük damarların anatomik varyasyonlarına bağlı ciddi yaralanmalar bildirilmiştir.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Damla tedavisine rağmen **3–5 günden uzun süren** veya kötü kokulu, yoğun kulak akıntısı
- **38,5 °C üzerinde ateş**, şiddetli kulak ağrısı
- Kulak arkasında kızarıklık, şişlik, kulak kepçesinin öne doğru itilmesi
- **Ani işitme kaybı**, şiddetli baş dönmesi, dengesizlik veya kusma
- Yüzde asimetri, ağız kenarında kayma veya gözü kapatamama
- Kulaktan yoğun kanama

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Tüp varken **kulağa kirli su (göl, deniz, havuz, banyo suyu) kaçmasından kaçınınız.** Duş ve banyoda vazelinli pamuk veya kulak tıkacı kullanılabilir. Yüzme hakkında hekiminizin önerisine uyunuz; genellikle kulak tıkacı ve/veya bone ile yüzeyde yüzmeye izin verilir, dalış önerilmez.
- Kulak çubuğu veya pamuklu çubukla kulak kanalının içini temizlemeyiniz.
- Kulak akıntısı olursa önce akıntıyı dışarıdan nazikçe siliniz ve size önerilen damlayı kullanarak hekiminize bilgi veriniz. Kendi kendinize başka kulak damlası kullanmayınız; bazı damlalar orta kulak için uygun değildir.
- Tüp düşse bile kontrol randevularına gelmeye devam ediniz; işitmenin ve kulak zarının durumunun takip edilmesi önemlidir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve "Size özel bilgiler" bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Tüpün belirli bir süre sonra kendiliğinden düşeceğini, tekrar sıvı birikirse yeniden tüp takılması gerekebileceğini ve kulak zarında kalıcı delik kalırsa kapatılması için ayrı bir ameliyat gerekebileceğini anladım.

☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**

☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.